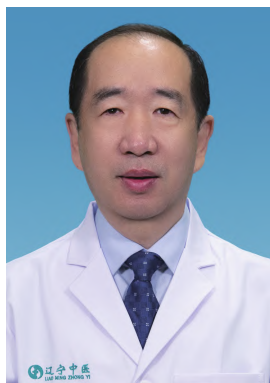


# 腹泻型肠易激综合征中医辨证思路与策略

王垂杰<sup>1</sup>



**专家简介:**王垂杰,辽宁中医药大学附属医院消化内科主任医师、教授、博士生导师,辽宁省名中医,国务院政府特殊津贴获得者,中华中医药学会脾胃病分会名誉副主任委员,世界中医药联合会消化疾病专业委员会名誉副主任委员,中国民族医药学会消化疾病专业委员会名誉副主任委员,中国研究型医院学会消化疾病专业委员会名誉副主任委员,中国中医药研究促进会消化整合专业委员会常委,中华中医药学会内科分会常委,辽宁省中医药学会脾胃病专业委员会名誉主任委员,辽宁省中西医结合学会消化专业委员会副主任委员,《中国中西医结合消化杂志》副主编,全国第六批、第七批中医药专家经验师承工作指导教师。主持、参加包括国家“973”“十五”“十一五”“十二五”重大科研专项和国家自然科学基金等课题 10 余项,辽宁省及沈阳市课题多项,荣获教育部科技进步二等奖 1 项,辽宁省科技进步二等奖 3 项,三等奖 3 项,市科技进步一等奖 1 项,市科技进步三等奖 1 项。发表论文 100 余篇,主编专著 5 部,副主编专著 3 部,参编 5 部。

**〔摘要〕** 腹泻型肠易激综合征是一种以腹痛、腹胀、排便习惯改变为主要临床表现的功能性肠病,其发病机制复杂,涉及多种因素共同作用。中医认为腹泻型肠易激综合征属于“腹痛”“泄泻”范畴,病因主要包括饮食不节、情志失调、外邪侵袭及先天禀赋不足等。病机关键为脾虚失运、升降失调,同时与肝失疏泄、心神失调、肾阳不足等多脏器功能紊乱密切相关。治疗上需多维度辨证施治,强调健脾温肾、调畅气机、补虚泻实、寒热同调及舒肝养心等综合策略,通过多靶点干预改善症状。本文结合中医理论与现代研究,系统阐述了腹泻型肠易激综合征的辨证思路与治疗对策,为临床实践提供参考。

**〔关键词〕** 腹泻型肠易激综合征;病因病机;中医辨证;多靶点治疗

**DOI:**10.3969/j.issn.1671-038X.2025.10.02

**〔中图分类号〕** R574 **〔文献标志码〕** C

## Diarrhea-Predominant irritable bowel syndrome: TCM syndrome differentiation approach and strategies

WANG Chuijie

(Department of Gastroenterology, Affiliated Hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Shenyang, 110032, China)

Corresponding author: WANG Chuijie, E-mail: lnzyxhk@163.com

**Abstract** Diarrhea-predominant irritable bowel syndrome( IBS-D) is a functional bowel disorder with abdominal pain, abdominal distension, and altered bowel habits. Its pathogenesis is complex and involves the interaction of multiple factors. Traditional Chinese medicine(TCM) believes that IBS-D belongs to the category of “abdominal pain” and “diarrhea”, and the etiology mainly includes dietary irregularities, emotional disorders, exogenous pathogenic factors, and congenital deficiency. The key pathogenesis is spleen deficiency leading to impaired transportation and disruption in the ascending and descending dynamics of qi, which is closely associated with dysfunction of multiple organs such as the liver(impaired soothing), the heart(mental disturbance), and the kidney(yang deficiency). Treatment requires multi-dimensional syndrome differentiation and treatment, emphasizing the comprehensive strategies including invigorating the spleen and warming the kidney, regulating qi and promoting the circulation of qi, tonifying the deficiency and purging the excess, regulating cold and heat, and soothing the liver and

<sup>1</sup> 辽宁中医药大学附属医院消化科(沈阳,110032)

通信作者:王垂杰,E-mail:lnzyxhk@163.com

nourishing the heart. Symptoms can be improved through multi-target intervention. Integrating TCM theory with modern research, this article systematically expounds the syndrome differentiation and treatment strategy of IBS-D, providing a reference for clinical practice.

**Key words** diarrhea-predominant irritable bowel syndrome; etiology and pathogenesis; traditional Chinese medicine syndrome differentiation; multi-target treatment

肠易激综合征(irritable bowel syndrome, IBS)是以反复发作的腹痛、腹胀或腹部不适为主要临床表现,与排便相关或伴随排便习惯/或粪便性状改变的肠道功能紊乱性疾病<sup>[1]</sup>。该病临床患病率较高,流行病学调查显示,我国普通人群 IBS 患病率为 1.4%~11.5%<sup>[2-3]</sup>。据其主要临床表现,罗马Ⅳ标准将其分为 4 种亚型:腹泻型肠易激综合征( IBS-D)、便秘型肠易激综合征( IBS-C)、混合型肠易激综合征( IBS-M)、未定型肠易激综合征( IBS-U)。其中约 3/4 的患者临床归属为 IBS-D<sup>[1]</sup>。IBS 发病的病理生理机制尚未完全阐明,目前认为多种因素共同作用引起的肠-脑互动异常可能是产生 IBS 症状的关键,其外周因素主要包括胃肠动力异常、内脏高敏感、肠黏膜通透性增加、肠道免疫激活及肠道微生态改变等<sup>[4]</sup>。

根据 IBS-D 的主要临床表现,中医可归属于“腹痛”“泄泻”范畴,其精神心理症状明显者亦可按“郁证”辨治。针对 IBS-D 病理机制的复杂性、临床表现的多样性,中医以其在整体观、辨证观指导下选用具有不同作用机制的中药组成的复方制剂,在多层次、多靶点上发挥着独特优势。

## 1 病因认识

### 1.1 饮食不节

《素问·太阴阳明论》曰“饮食不节,起居不时者,阴受之……则膜满闭塞,下为飧泄。”明代王伦《明医杂著》则云:“惟饮食不节,起居不时,损伤脾胃,胃损则不能纳,脾损则不能化,脾胃俱损,纳化皆难,元气斯弱,百邪易侵,而饱闷、痞积、腹痛、泄痢等证作矣。”

随着现代人们生活习惯改变,饥饱失常,过食肥甘厚味、辛辣刺激性食物致脾胃运化失司,中焦气机升降失常而致腹痛、腹泻的发生。现代研究显示,84%的 IBS 患者症状的发生与饮食有关,如摄入不能被完全吸收的碳水化合物类食物、富含生物胺的食物、刺激组胺释放的食物、油炸类和含脂肪食物,均可造成肠道微生态菌群的改变,诱发肠道免疫应激、高敏感反应进而发生腹痛、腹泻、腹部不适等症状。而诸多的现代研究结果均表明不当的饮食是 IBS 发生的重要因素。诱发胃肠道症状的食物数量与 IBS 症状的严重程度呈正相关<sup>[5]</sup>。

### 1.2 情志失调

研究表明,IBS 患者在情感、学习、认知行为能

力、精神心理方面存在能力障碍与缺陷。相当比例的 IBS 患者伴有不同程度的精神情绪障碍,包括焦虑、紧张、抑郁、压力、失眠和神经过敏等,其中抑郁或焦虑障碍是 IBS 的显著危险因素,在 IBS 患者中的发生率为 40%~60%<sup>[6]</sup>。

中医学认为,在七情过激、心理失衡、负性生活事件加持和创伤后应激等因素作用下导致心神失养和肝失条达是引发焦虑或抑郁等情感障碍的直接原因。

### 1.3 外邪致病

外感暑、湿、寒、热之邪,特别是感受湿热之邪者,最易困阻脾土,以致升降失职,清浊不分,水谷混杂而下发生泄泻。由于湿邪具有重浊黏滞易阻滞气机的病理特性,故外感湿热邪的急性期过后往往反复出现腹痛、腹胀、腹部不适伴有大便黏滞不爽等症,且时起时伏,缠绵难愈。现代医学研究亦证实部分 IBS-D 患者既往曾有被肠道细菌、病毒等病原微生物感染过的急性胃肠炎类病史,而感染消退后仍存在持续的胃肠道功能紊乱的症状,即所谓“感染后肠易激综合征(PI-IBS)”。其机制可能是中医归属于湿热之邪的各种细菌、病毒引起肠黏膜肥大细胞或其他免疫炎症细胞释放炎症细胞因子,引起肠道功能紊乱<sup>[6]</sup>。

### 1.4 先天禀赋

人的体质形成,离不开先天禀赋、遗传背景。不同个体的体质特征与许多特定疾病的产生有密切的关系。一项针对 247 例 IBS 患者的研究<sup>[7]</sup>中发现,IBS-D 9 种中医体质中,阳虚质占 33.3%,气郁质占 32.1%,结论为腹泻型患者的阳虚质及气郁质为主。另一项研究对 241 例 IBS 患者进行了 314 种食物过敏源 IgG 抗体的测定,发现多数患者存在鸡蛋、牛奶过敏源 IgG 抗体检测阳性,且 IBS 患者更易对虾、蟹、大豆等正常人不易过敏的食物产生过敏,表明 IBS 发病与特禀体质(过敏体质)有密切关系<sup>[8]</sup>。需要指出的是,这种特禀体质更多地表现为对一些食物的不耐受,引起肠道免疫应激反应,进而诱发或加重 IBS 症状。

## 2 病机分析

### 2.1 病位

IBS 病位在肠,与脾、心、肝、肾的功能失调密切相关。且各脏腑功能相互影响,临床往往形成多脏器合病,进而形成虚实夹杂、寒热错杂证候。

## 2.2 脾虚失运、升降失调是 IBS-D 的病机关键

《沈氏尊生书》：“泄者，脾病也。”当今之人，奔波劳碌，饮食无常，又加饮食结构及习惯的变化，偏嗜冷饮、烟酒、辛辣厚味，长此以往则脾胃必损，脾气虚弱，水谷运化失司，清气不升，则气滞、湿阻、痰结、食积等因为患而发病。“清气在下，则生飧泄”，脾虚中州运化无力，若水谷不能转精微，谷不为精而聚为湿浊，湿濡肠道便发腹泻，故本病之本在于脾虚，其诱发腹痛、腹泻、腹部不适等症状，乃是通过患者内在的脾虚因素而起作用的，正如《景岳全书·泄泻》云：“泄泻之本，无不由于脾胃”。

脾虚失运、升降失调既表明机体对肠道的调控能力下降，出现肠动力紊乱，导致结肠蠕动过快或引发肠道痉挛，诱发腹痛、腹泻发生；又可致肠道菌群失衡（有益菌如双歧杆菌等减少、有害菌如变形杆菌等增多）、菌群代谢产物（如短链脂肪酸）生成不足，这样既会削弱肠道黏膜的修复能力、又会干扰肠道动力调节，导致升降失调持续存在，使腹痛、腹泻等症状迁延不愈。

## 2.3 肝失疏泄、风木犯脾是 IBS-D 的重要发病机制

肝脏具有调畅情志，助脾运化之功能。唐容川在《血证论》中说“木之性主于疏泄，食气入胃，全赖肝木之气以疏泄之，而水谷乃化，设肝之清阳不升，则不能疏泄水谷，渗泄中满之症，在所不免。”说明肝木条达则枢机调畅，上能疏达脾土以助运化，下可调畅肠腑以助传导。若平素性情抑郁或精神因素刺激，肝气不舒，无力升发，疏泄失职，则必然不利于脾胃运化及肠腑传导功能的发挥。《景岳全书·泄泻》所云：“凡遇怒气便作泄泻者，必先以怒时夹食，致伤脾胃，故但有所犯，即随触而发，此肝脾二脏之病也。”若肝木疏泄太过，大肠传导失职，则发生腹泻。《医学入门》则云：“腹中之痛，称为肝气郁结，木郁不达，风木冲击而贼脾土，则痛于脐下”，肝气郁滞，疏泄不及而横逆犯脾，脾胃升降之气因而壅阻，气机阻塞不通则成腹痛。可见肝失疏泄，肝脾失和是导致 IBS-D 发生的重要发病机制。

从肝失疏泄的核心表现（情绪异常引发/加重肠道症状、肠功能紊乱）看西医病理机制，其本质就是情绪-神经-内分泌-免疫网络失调对肠道功能的影响。长期焦虑、抑郁等情绪因素会激活中枢神经系统的应激通路，导致神经递质（5-羟色胺等）分泌紊乱，这些递质不仅调控情绪，还直接作用于肠道神经，引发肠道动力增强，肠液分泌增多最终导致腹泻、腹痛。而肝脾失和的内在病理机制则多体现为脑-肠轴双向调节失衡；中枢情绪异常信号通过神经、内分泌途径传导至肠道，抑制肠道消化吸收功能增强肠道敏感性；同时肠道菌群紊乱、肠道炎

症因子释放增多，又会反向传递信号至大脑，加重情绪焦虑、抑郁，形成情绪→肠道→情绪的恶性循环。

## 2.4 心神失养是 IBS-D 加重病情的内在因素

诸多研究已证实抑郁或焦虑障碍是 IBS 的显著危险因素<sup>[1]</sup>。从中医角度分析这些抑郁或焦虑障碍产生的原因除了肝失疏泄，不能很好地调畅情志之外，还与心神失养密切相关。因为心是人进行精神意识思维活动的主要内脏，是人体情志的发生之处和主宰者。正如张介宾在《类经》中所说：“情志之伤，虽五脏各有所属，然求其所由，则无不从心而发。”情志失调最易伤及心神，进而使心主神明功能异常，心神失调，母病及子，使脾气郁结，气机不畅，影响其水湿的转运，进而出现腹痛、腹胀、腹泻等症状同时伴有情绪低落、焦躁不安、食少纳呆、心慌心悸、失眠多梦等诸多情志失常表现。此类伴有精神情志临床表现的 IBS-D 患者其病情往往较重，心神失养是其重要的病理因素。

西医视角下“心神失养”的病理机制主要是中枢神经功能异常及脑-肠轴调控失衡。中枢层面：心神失养导致大脑对肠道感觉信号的“过滤”能力下降，轻微肠道刺激即可放大为明显腹痛，即“内脏高敏感”。而在肠道层面：肠道菌群紊乱，肠道炎症因子释放增多，会通过血液循环反向传递信号至大脑，进一步加重中枢神经递质紊乱，最终形成心神失养→肠道不适→心神更失养的恶性循环，这是 IBS-D 病情发展加重的主要内在机制。心神失养还主要表现为对情绪应激的耐受能力下降，易导致 HPA 轴（人体核心应激通路）过度激活，使肾上腺分泌皮质醇增多，过量的皮质醇不仅会加重情绪焦虑（进一步损伤心神），还会直接作用于肠道平滑肌，加快肠道蠕动速度，减少水分吸收；同时还会降低肠道黏膜屏障功能，增加肠道敏感性，诱发腹泻、腹痛的发生。

## 2.5 肾阳不足，脾阳失其温煦是 IBS-D 缠绵难愈的病理基础

临床常见素体虚弱或年老体虚的 IBS-D 患者腹部冷痛、遇凉即泻、得温痛减、形寒肢冷、腰膝酸软、完谷不化等表现，究其由乃脾肾阳虚，肠腑失于温煦所致。该病初期阶段多为脾气虚弱，健运失司，不能运化水湿所致，然泻之日久必损伤脾阳。脾之运化水谷精微既赖肾阳以温煦化生万物，同时又依脾之运化来滋补肾阳，脾肾阳气虚衰，后天难以充养先天，致肾阳难以充盛，久则脾肾阳气俱虚，终成久虚不愈之证。正如张介宾所言：“泄泻之本，无不由于脾胃，肾为胃关，开窍于二阴，所以二便之开闭，皆肾脏之所主，今肾中阳气不足，则命门火衰



……阴气盛极之时,即令人洞泄不止。”

肾阳虚的内在病理机制的本质特征是多系统功能减退及调控网络失衡。如肾阳虚患者常以交感神经功能减弱,副交感神经功能亢进为特点。交感神经功能减弱会降低肠道平滑肌的兴奋性和收缩协调性,导致肠道动力紊乱,且肠道对水分的吸收能力下降,引发长期稀溏便;副交感神经亢进则会增加肠道敏感性,使肠道对寒冷、饮食刺激的反应更剧烈出现遇寒腹泻加重的表现。肾阳虚患者肾上腺分泌的皮质醇等激素水平可能降低,导致机体对情绪、寒冷等应激的耐受能力下降、肠道黏膜屏障功能减弱,易受菌群或炎症因子刺激,同时伴随免疫功能下降,机体无法有效调节肠道微生态平衡和炎症状态,导致 IBS-D 病程迁延,成为缠绵难愈的重要病理基础。

综上所述,IBS-D 病因多样,非一种因素致病;病机复杂,多脏器功能失调参与其中。临床不仅出现不同程度的腹痛(隐痛、胀痛、冷痛、绞痛)、腹胀、腹部不适、肠鸣、排气增多或排气不畅、排便次数增多或排便不尽感、大便清稀、大便糖稀、大便黏滞不爽等诸多消化道症状,又常伴有疲倦乏力、肢体发凉、怕冷畏风、头晕头痛、口干口苦等全身症状以及心境低落、心烦失眠、急躁易怒等情志失调表现。这些繁杂多样的临床症状折射出 IBS-D 胃与肠,上下交损;脾与肾相互影响;虚与实相互交织;寒与热错杂其中;肝与心失调失养等病机特点。这也是临床用任何单一治疗方法均不能很好地取得满意疗效的原因所在。只有全面分析 IBS-D 发病因素和病机特点,多维度、全方位考量“上与下”、“虚与实”、“寒与热”、“脾与肾”、“肝与脾”、“心与脾”、“肝与心”在 IBS-D 发病过程中的因果与连带关系,才能更准确地把握 IBS-D 的发病机制,以此“对证下药”方可取得满意疗效。

### 3 治疗思路与对策

#### 3.1 健脾常须温肾,温补脾肾,强本助运

脾气虚弱,运化失司是 IBS-D 的基本病机,健运脾气是 IBS-D 最基本治则。然肾为一身阳气之根本,脾之运化依赖肾阳之温煦,而肾中阳气亦需脾气之滋养,后天脾气、脾阳与先天之肾阳相互依存、相互影响。脾气虚、脾阳不足日久累及肾阳,终至命门火衰,脾肾阳虚之证。故临床对 IBS-D 须依病患禀赋之强弱,病史之长短,年龄之老幼,辨病位之深浅,浅者在脾(脾气虚、脾阳虚),治以健脾温中为主;深者在肾(脾肾阳虚),治以温补脾肾为要。

若平日神疲乏力,纳呆食少,头身困重,稍多饮食即出现大便稀溏伴便不净感,腹部胀满,舌体胖大色淡,边有齿痕,苔白腻,脉弱,为脾胃虚弱证,在

治疗上重在健脾益气、化湿止泻,可用参苓白术散加减;若出现腹部冷痛,喜温喜按,遇冷加重,腹泻,时泻时溏,少食纳差,倦怠乏力,舌质淡、边有齿痕,脉沉细者,为脾阳不足证,在治疗上宜温中健脾、散寒止泻,方可选用黄芪建中汤或理中丸加减;若见五更痛泻,粪质清稀,完谷不化,形寒肢冷,小腹冷痛,小便清长,腰膝酸软,舌淡胖,苔白滑,脉沉缓者,则为脾肾阳虚证,在治疗上宜温补脾肾,选用附子理中丸或四神丸加减。

用药选择:当脾虚运化无力,导致湿盛出现腹部隐痛喜按、泄泻者,予党参、白术、茯苓、莲肉、薏苡仁、山药、扁豆等以健脾化湿;当脾胃气机阻滞,湿邪积滞中焦,出现腹部胀满不舒、泄泻时,予砂仁、苍术、厚朴、陈皮、白蔻等以化湿醒脾;脾阳不足进而累及肾阳出现中焦虚寒腹痛喜温喜按、大便稀溏者,则予干姜、附子、补骨脂、肉桂、小茴香等以温里散寒;此外,临床亦常选五味子、乌梅、赤石脂、石榴皮、菟丝子、金樱子、肉豆蔻等收敛之品以增涩肠止泻之效。

#### 3.2 治下勿忘治上,异病同治,重在治本

大量的临床研究已证实 IBS 与 FD、GERD 存在较高比例的同时患病的重叠现象<sup>[9]</sup>。即腹痛、腹胀、腹泻患者常同时患有胃胀、嗝气、早饱、烧心、反酸等上消化道症状。临证之时要上下同时考量,针对重叠现象的病机所在选方用药。

当脾胃虚弱运化失常,致使中焦气机不畅而滋生痞满,并引起大肠传导功能障碍,出现脘腹胀满、纳少、泄泻等症状时,宜补中益气,选用补中益气汤或升阳益胃汤等加减治疗,重在补脾益胃、强本固基;当中焦脾胃气机逆乱升降失司,出现上有胃脘胀满、嗝气、泛酸、嘈杂,下有大便溏时,为肠胃不和证,在治疗上宜消痞散结、调和肠胃。据病情方可选用半夏泻心汤、胃苓汤、枳实消痞丸等加减治疗,意在以调畅肠胃气机、散结消痞;当情志不调,肝失疏泄,使脾失运化,气机升降失调,患者除反复脘胁痞胀痛、纳少、嗝气,排便异常外,还伴随心烦易怒等情志症状,则属肝胃(脾)不和证,在治疗上选择调和肝脾(胃)法,用逍遥散或柴胡疏肝散合痛泻要方加减治疗,重在疏肝行气,扶脾健运。

胃与肠症状重叠病机之关键乃气机升降失常,故胃肠同病之重点在于调畅气机。临床上调气药物常为重要选择。据临证所需或补中益气,或疏肝行气,或行气散满,或降逆消痞,或行气化湿。用药选择,当肝郁明显,出现胸胁胀满、嗝气时,常予柴胡、香附、佛手、香橼等以疏肝理气;当脾胃气机阻滞,出现胃脘痞闷、腹部胀满不舒时,常予陈皮、厚朴、木香、苏梗、枳壳等以理气调中;当胃气上逆出

现暖气、呃逆、呕吐症状时,常予半夏、旋复花、代赭石等以降气止呕;当脾虚无以运化水湿出现纳少、呕吐、泄泻时,常予砂仁、白豆蔻等以行气化湿。

### 3.3 补虚勿忘泻实,虚实兼顾,消补兼施

本病虽以脾胃虚弱为最基本病机,但由于病程的迁延、多种病因的影响,脏腑间生克制化的相互作用,常出现错综复杂的病理变化,临床上虚实夹杂之证最为常见。临床上在脾虚证见的同时又常可见气滞、湿阻、郁热、寒凝等实证表现。故临证须虚实兼顾,采用补虚泻实、消补兼施之法。依四诊所见,仔细评估虚实状态。虚多实少者,以补配消;实多虚少,以消配补。如脾虚兼湿邪阻滞者,可选升阳益胃汤、升阳除湿汤、调中益气汤等加减化裁;若脾阳不足兼见肝郁气滞者可选黄芪建中汤和痛泻要方,或和柴胡疏肝散加减化裁;若脾虚兼见食积者可选人参健脾丸加减化裁。

用药选择,在补益脾胃升阳止泻基础上,若见肝气郁滞之症可选柴胡、香附、白芍、香橼等药以舒肝行气、柔肝缓急止痛;若见湿邪阻滞之症可选炒苍术、厚朴、砂仁、豆蔻、佩兰等药以除湿止痛。

### 3.4 寒热常要同调、随证应变、调和阴阳

脾为阴土,喜燥恶湿,易为寒湿所困,故临床上IBS患者常在脾虚基础上进一步发展成脾阳不足证或脾肾阳虚证,但由于在疾病发生发展过程中,常因饮食不节,嗜食辛辣刺激食物,或因工作紧张,学习压力大,家庭负担重等因素而生成内火如胃火、脾火、肝火、心火等,火热之邪,最易与湿相合而成湿热之证。故而临床上常见患者既有腹部冷痛、泻下清稀、喜温喜按等阳气不足所致之虚寒证见,又常伴口干口苦、舌苔黄腻、口舌生疮、心烦易怒、反酸、烧心等阳盛所致郁热或湿热表现。因此对这类寒热互见、寒热错杂之证,须用寒热并调之法,其用药理念如李东垣所言:“今所立方中,有辛甘温药者,非独用也;复有甘苦大寒之剂,亦非独用也,以火、酒二制为之使,引苦甘寒药至顶,而复入于肾肝之下,此所谓升降浮沉之道,自耦而奇,奇而至耦者也。”常用方剂如半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤、补脾胃泻阴火升阳汤、乌梅丸等。用药原则则权寒热之轻重选药配伍。寒重而热轻者,重用甘温补益、温里散寒之药,酌用清热药;热重而寒轻者,则重用清热药、泻火药或清热燥湿药而酌用甘温补益药或温里散寒药。以此以达寒热调和、阴阳自洽之效。

### 3.5 疏肝勿忘养心,医心为本,治神为要

IBS是一种肠-脑互动异常性疾病,属消化系统心身疾病。IBS患者常伴发焦虑、抑郁、紧张、压力、失眠和精神过敏等表现。基于这些精神情志方

面的临床表现,中医多认为病属肝气郁滞、疏泄失司所致,故临床多从肝论治,或疏肝理气或柔肝养血或清肝泻热等立法选药。但临证时决不能忽视心神在IBS发病过程中的重要作用,心神失养则会导致精神情志失常等诸多临床表现。根据IBS脑-肠互动紊乱的发病机制,有学者提出“脑-肠同调”的治病理念<sup>[10]</sup>,将IBS的中医治疗视角提升了一个新的维度。因为中医心主神志的功能基本等同于脑的功能,故“脑-肠同调”也可以说是“心-肠同调”。近年来已有多位学者认识到心神在IBS发病中的重要作用,提出从心论治的治疗理念<sup>[11-14]</sup>。可以说从心论治是针对IBS发病机制脑肠互动紊乱的靶点而设的不可或缺的重要治疗理念。正如《素问》所言:“精神不进,志意不治,故病不可愈。”华佗在《青囊秘录》中亦云:“善医者先医其心,后医其身。”均强调了调心安神在诊治患者过程中的重要性。在临床诊治过程中要倾听患者苦恼,了解其心理疑虑,尽量解除其恐病的心理负担可以说是治疗的前提。在辨证上依据其四诊所见,其造成心神失养的病机所在而选方化裁用药。如肝郁血虚者用逍遥散,心火亢胜者用朱砂安神丸,胆热痰扰者用温胆汤,心胆气虚者用安神定志丸、酸枣仁汤,阴虚火旺者用黄连阿胶汤、交泰丸,心脾两虚者用归脾汤,心肝火旺者用栀子豉汤等加减治疗。

在用药选择上,依据其情志失调的病机所属,可酌情选用柴胡、香附、香橼、佛手、玫瑰花、绿萼梅、夏枯草、栀子、龙胆草等以疏肝解郁、清肝泻火;选用远志、五味子、茯神、石菖蒲等宁心安神;选用酸枣仁、柏子仁、夜交藤、龙眼肉以养心安神;选用百合、竹叶、黄连以清心安神。总之,IBS-D是一种致病因素多、发病机制复杂、临床症状表现繁杂不一的功能性肠病。单一的治疗方法往往难以获得满意疗效。临证之时须多维度、多层次综合分析其症状产生的病理机制,制定多靶点干预的治疗策略,在选方用药上要针对其病机特点和症状表现特点,采用上下同治、虚实兼顾、寒热同调、脾肾共济、调肝养心等多层级、多靶点的综合考量,方能精准用药、切中要害,取得满意疗效。

**利益冲突** 作者声明不存在利益冲突

### 参考文献

- [1] 中华医学会消化病学分会胃肠功能性疾病协作组,中华医学会消化病学分会胃肠动力学组.2020年中国肠易激综合征专家共识意见[J].中华消化杂志,2020,40(12):803-818.
- [2] Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, et al. Worldwide prevalence and burden of functional gastrointestinal disorders, results of Rome foundation global study[J]. Gastroenterology, 2021, 160(1): 99-

- 114.
- [3] Xiong LS, Chen MH, Chen HX, et al. A population-based epidemiologic study of irritable bowel syndrome in South China: stratified randomized study by cluster sampling[J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2004, 19(11): 1217-1224.
- [4] 戎新倩, 舒青龙. 基于脑-肠-微生物轴的肠易激综合征机制与治疗研究进展[J]. *微生物学通报*, 2023, 50(9): 4190-4205.
- [5] 张璐, 段丽萍, 刘懿萱, 等. 中国人群肠易激综合征患病率和相关危险因素的 Meta 分析[J]. *中华内科杂志*, 2014, 53(12): 969-975.
- [6] Koloski NA, Jones M, Talley NJ. Evidence that independent gut-to-brain and brain-to-gut pathways operate in the irritable bowel syndrome and functional dyspepsia: a 1-year population-based prospective study[J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2016, 44(6): 592-600.
- [7] 葛国艳. 肠易激综合征与体质的相关性研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2010.
- [8] 张燕华, 毛峻岭, 张丽航, 等. 根据食物特异性 IgG 抗体剔除过敏食物治疗肠易激综合征[J]. *胃肠病学和肝病学杂志*, 2011, 20(2): 178-180.
- [9] 胡佳艳, 乔希筠, 王昱茜, 等. 基于“枢轴运动”理论论治功能性胃肠病症状重叠[J]. *时珍国医国药*, 2024, 35(7): 1703-1705.
- [10] 潘雨烟, 毛心勇, 刘倩, 等. 基于“脑肠同调”治疗腹泻型肠易激综合征[J]. *中医杂志*, 2021, 62(13): 1130-1133.
- [11] 吴皓萌, 秦书敏, 郑欢, 等. 从心肝脾论治腹泻型肠易激综合征伴焦虑或抑郁状态[J]. *中华中医药杂志*, 2021, 36(8): 4494-4497.
- [12] 毛心勇, 陈建德, 荣培晶, 等. 探讨“脑肠同调”治疗常见功能性胃肠病[J]. *中国中西医结合杂志*, 2020, 40(5): 628-632.
- [13] 孟丽媛, 高明周, 张浩, 等. 从精神心理角度探析肠易激综合征发病与诊疗[J]. *现代消化及介入诊疗*, 2021, 26(11): 1345-1348.
- [14] 吴皓萌, 秦书敏, 郑欢, 等. 从中医心功能失调探讨肠易激综合征病机[J]. *中华中医药杂志*, 2021, 36(9): 5162-5164.

(收稿日期: 2025-06-17)